

13- Le Cœur_Diastole & Systole

Le cœur, il va stocker de l'énergie dans un environnement facial, où il va soutenir l'électricité du cœur, dans sa montée et dans sa descente. Il y a comme une empreinte d'une facilité. Il y a des gens qui sont dans une fonction systolique, ou plus dans une fonction diastolique. Normalement, il doit avoir à peu près un équilibre. D'une certaine façon, il va répéter son mouvement embryonnaire, de façon assez directe, dans son mouvement. Tu vas sentir un mouvement plutôt comme ceci, Par exemple, des gens qui sont trop dans un mouvement de systole, ce sont des gens qui recherchent, et qui à la fois peuvent aller dans l'épuisement. Ou inversement, ce sont des gens qui partent ici, et qui sont toujours à la recherche de ce point d'appui, en bas. Vous vous souvenez, le cœur fait cette espèce de looping, où le système ventriculaire, qui était au-dessus, devient en dessous, avec un point d'appui important, dans l'espace entre les oreillettes et les ventricules. Au moment où le cœur fait une systole, il va faire une montée, un mouvement de supination, il va avoir tendance à se verticaliser, et il fait une détorsade. C'est là où il y a un mouvement de la horte, qui s'ouvre, pourquoi ? Pour accueillir tout le sang. Donc il y a une espèce de congestion qui va se faire ici, et au moment où il va descendre, tout le sang de la horte part dans le système. C'est pour ça que parfois, il y en a qui vont confondre le mouvement systolique avec le mouvement de descente. Je vois que la systole, c'est le moment où il va éjecter. Et c'est pour ça que quand il redescend, il se re-remplit. Où je fais ça, donc j'éjecte le volume, mais j'augmente ma pression dans mon système de la crosse de la horte. Par contre, au moment où je descends, je remplis, mais j'éjecte la horte. Est-ce que vous avez à voir l'impression que le cœur a tendance à se verticaliser, ou à s'horizontaliser ? Est-ce que le cœur se verticalise et monte, est-ce que le cœur se verticalise et monte, ou s'il s'horizontalise et descend ? ou s'il s'horizontalise et descend ? On va prendre trois points d'appui. Un point d'appui qui sera au niveau de l'espace aortique, Un point

d'appui qui sera au niveau de l'espace aortique, qui est le deuxième espace intercostal ici, et un espace pulmonaire, et un espace pulmonaire, et l'aminance hypothénale va se déposer sur la pointe du cœur, va se déposer sur la pointe du cœur, comme ceci. comme ceci. Le cœur va réagir en fonction Le cœur va réagir en fonction de deux grands systèmes qui lui sont très proches, de deux grands systèmes qui lui sont très proches, un en fonction du foie, deux en fonction de l'estomac, deux en fonction de l'estomac, trois en fonction des poumons, trois en fonction des poumons, et quatre en fonction des reins. et quatre en fonction des reins. Il va toujours essayer dans son environnement de aider au maximum de aider au maximum les poumons, le foie, l'estomac et les reins. le foie, l'estomac et les reins. de maintenir cette pression. Parce que c'est un régulateur de volume. On doit considérer le cœur comme une grosse artère avec la horte jusqu'en bas. Donc considérez vraiment ça comme un... l'octopus. supination. ici, ça va être un mouvement de pronation. Donc on a ça, comme ça. On va voir son environnement, comment il est mis, et puis on va mettre les mains au niveau du foie et on va voir comment il va réagir sur un plan facial. La horte, si tu regardes bien à un niveau anatomique, elle part en fait assez derrière, comme ça. Donc c'est difficile de la voir. On sait juste qu'elle est avec un environnement facial commun, avec les bronches et l'œsophage, tu vois, qui vient s'insérer au niveau de cette vertèbre qui est très fréquemment en adaptation. Ça s'appelle la zone rythmique. Ça c'est une zone neurosensorielle, ça c'est la zone rythmique, ça c'est la zone métabolique, ça c'est la zone urogenitale. Le cœur, pour avoir un bon mouvement, doit avoir une bonne relation avec le diaphragme. Alors il y a une relation directe via cette continuité faciale de la crosse et de la horte. Rappelez-vous le passage de la horte, qui est très profond, où ça vient vraiment de part et d'autre, les piliers diaphragmatiques. Pour travailler un cœur, il faut absolument que le diaphragme soit

ouvert et souple. N'oubliez pas qu'il y a encore un autre passage important, qui est par rapport à l'œsophage. Hier, on a vu le fulcrum embryonnaire, prépaternel qui se mettait au niveau de la ligne primitive, au niveau coccyx, avec le point d'arrivée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la main au niveau du cœur, et on va laisser la main suivre le mouvement facial. Le tissu, si tu te mets à l'écoute, il va te montrer si le cœur est plutôt vers la systole ou vers la diastole. à mon foie qui réagit ? Est-ce que c'est par rapport à mon estomac ? Ou est-ce que c'est par rapport à mes reins ? Trois niveaux. Et puis on va voir si ça peut se rééquilibrer par rapport à là.